

TEMA 9.7 • RESPIRATORIO

Score de Tal

PERFIL EUNACOM 3.01.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Bronquial Obstructivo (SBO)** es un cuadro clínico caracterizado por inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias bajas, manifestándose principalmente con sibilancias, espiración prolongada y aumento del esfuerzo respiratorio. Es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencias pediátricas en Chile.

Evaluación de la Severidad: Score de Tal

La decisión terapéutica en el SBO se basa estrictamente en la severidad del cuadro, la cual se mide mediante el **Score de Tal**. Este puntaje evalúa cuatro parámetros: frecuencia respiratoria (según edad), presencia de sibilancias, uso de musculatura accesoria (retracción) y cianosis.

TABLA 9.7.1: PUNTAJE VS FRECUENCIA RESPIRATORIA (< 6 MESES)

PUNTAJE	FRECUENCIA RESPIRATORIA (< 6 MESES)	FRECUENCIA RESPIRATORIA (> 6 MESES)	SIBILANCIAS	RETRACCIÓN (TIRAJE)
0	≤ 40	≤ 30	Ausentes	Ausente
1	41 - 55	31 - 45	Fin de espiración	Leve (intercostal)
2	56 - 70	46 - 60	Inspiratorias y espiratorias	Moderada (generalizada)
3	> 70	> 60	Audibles a distancia / Silencio	Grave (supraesternal/aletas)

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del SBO: El proceso obstructivo resulta de una combinación de tres factores: edema de la mucosa bronquial, hipersecreción de mucus y broncostricción (contracción del músculo liso). En lactantes pequeños, el componente inflamatorio y de secreciones suele ser predominante sobre el broncoespasmo.

Manejo según Severidad

1. SBO Leve (Score de Tal 0 - 5)

El manejo es ambulatorio. Un puntaje de 0 no constituye diagnóstico de SBO, pero en el rango de 1 a 5 se procede de la siguiente manera: - **Tratamiento:** Se administran **2 puffs de Salbutamol** (100 mcg cada uno) mediante aerocámara. - **Disposición:** Alta para el hogar con indicaciones claras. - **Educación:** Se debe entregar una hoja de reconsulta con **signos de alarma:** - Fiebre alta o persistente (sospecha de sobreinfección bacteriana o **Neumonía Adquirida en la Comunidad**). - Aumento del esfuerzo respiratorio (hundimiento de costillas). - Dificultad para alimentarse o rechazo alimentario. - Compromiso del estado general.

2. SBO Moderado (Score de Tal 6 - 8)

Requiere manejo en el servicio de urgencia o sala de procedimientos (Sala IRA). - **Tratamiento inicial:** Se realiza un "set de rescate" que consiste en **2 puffs de Salbutamol cada 10 minutos por 1 hora** (total 6 veces). - **Reevaluación:** Al cabo de una hora se evalúa la respuesta. Si el paciente mejora, puede continuar manejo ambulatorio; si no mejora o empeora, se debe considerar el escalamiento terapéutico o la hospitalización. - **Vía de administración:** Se prefiere el uso de Inhalador de Dosis Medida (MDI) con **aerocámara** por sobre la nebulización, ya que es más costo-efectiva, fácil de usar y tiene menos efectos adversos.

3. SBO Severo (Score de Tal 9 - 12)

Es una emergencia médica que requiere estabilización inmediata. - **Prioridad:** Corregir la **hipoxemia**. - **Tratamiento:** Oxigenoterapia para mantener saturación ≥ 93%, broncodilatadores de rescate y evaluación inmediata para hospitalización.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: La medida más importante en cualquier cuadro respiratorio agudo es la corrección de la hipoxemia. Si el paciente desatura (<93%), el oxígeno es la primera medida, independientemente del puntaje del Score de Tal.

Farmacoterapia Específica

Salbutamol e Ipratropio

El **Salbutamol** (beta-2 agonista) es el pilar del tratamiento. Sin embargo, en ciertos escenarios se prefiere o se añade **Bromuro de Ipratropio**. - **Indicaciones de Ipratropio:** - Pacientes con efectos adversos marcados por Salbutamol (taquicardia severa, temblor). - Pacientes cardiopatas. - Pacientes que ya han recibido dosis altas de Salbutamol en domicilio sin respuesta. - **Uso combinado:** Habitualmente se utiliza mezclado con dosis más bajas de Salbutamol para potenciar el efecto broncodilatador por dos vías distintas.

Corticoides

Los corticoides sistémicos (betametasona, prednisolona) no se usan de rutina en casos leves, pero son fundamentales en: - **SBO Recurrente:** Ayudan a disminuir la duración de la crisis y evitar recaídas. - **Falta de respuesta:** Si el paciente no mejora tras 1-2 horas de tratamiento con broncodilatadores. - **SBO Severo:** Todo paciente que se decide hospitalizar debe recibir corticoides.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Error común: No confundir el manejo de la crisis aguda con el tratamiento de mantención. El uso de corticoides inhalados (como Fluticasona) es para el control a largo plazo del **Asma Bronquial** o SBO recurrente, no para el rescate en el servicio de urgencia.

Criterios de Hospitalización

La decisión de hospitalizar se basa en la severidad clínica y la respuesta al tratamiento inicial:

- **Severidad extrema:** Score de Tal de 11 o 12 puntos al ingreso.
- **Fracaso al tratamiento en SBO Severo:** Score de 9-10 que persiste por más de 1 hora a pesar del manejo.
- **Fracaso al tratamiento en SBO Moderado:** Score de 6-8 que persiste por más de 2 horas sin mejoría significativa.
- **Factores sociales:** Incapacidad de los cuidadores para cumplir el tratamiento o lejanía del centro de salud.
- **Comorbilidades:** Prematurez extrema, cardiopatías congénitas o enfermedades neuromusculares.

Resumen de la Evidencia

Aunque las guías clínicas recomiendan ampliamente el uso de broncodilatadores y corticoides, es importante notar que: - El **oxígeno** es la intervención con mayor evidencia de beneficio en cuadros graves. - El uso de puffs con aerocámara es equivalente o superior a las nebulizaciones en la mayoría de los pacientes. - El manejo debe ser dinámico: si el paciente se agrava antes de completar la hora de observación, se debe reevaluar y actuar de inmediato.

NOTA CLÍNICA

Recuerda que el SBO en menores de 2 años puede ser la manifestación de una **Bronquiolitis Aguda**, donde la respuesta a broncodilatadores es variable y el pilar es el soporte (aseo nasal, hidratación y oxígeno).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 9 meses consulta por dificultad respiratoria. Al examen: frecuencia respiratoria 50/min, retracción intercostal, sibilancias espiratorias e inspiratorias, sin cianosis. ¿Cuál es el puntaje del score de Tal y su clasificación de severidad?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Score de Tal. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Score de Tal: leve 0-5, moderado 6-8, severo 9-12 puntos (máximo 12)
- Evalúa 4 variables: frecuencia respiratoria, musculatura accesoria, cianosis y sibilancias
- Frecuencia respiratoria: puntos de corte 30, 45, 60 (suben de 15 en 15); en <6 meses se suma 10
- Musculatura accesoria en SBO progresa de abajo hacia arriba: subcostal (1), intercostal (2), cervical (3)
- En laringitis obstructiva la progresión es inversa: de arriba hacia abajo
- Cianosis: perioral con llanto (1), perioral constante (2), generalizada (3)
- Sibilancias: espiratorias (1), inspiratorias + espiratorias (2), audibles sin fonendoscopio o silencio pulmonar (3)
- El silencio pulmonar en un paciente con signos de gravedad indica SBO muy severo (3 puntos)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SCORE DE TAL)**PREGUNTA 1**

Lactante de 9 meses consulta por dificultad respiratoria. Al examen: frecuencia respiratoria 50/min, retracción intercostal, sibilancias espiratorias e inspiratorias, sin cianosis. ¿Cuál es el puntaje del score de Tal y su clasificación de severidad?

- A) 4 puntos, SBO leve
- B) 8 puntos, SBO moderado
- C) 6 puntos, SBO moderado
- D) 7 puntos, SBO moderado
- E) 6 puntos, SBO leve

PREGUNTA 2

Lactante de 4 meses con SBO presenta frecuencia respiratoria de 58/min. Según el score de Tal, ¿cuántos puntos corresponden a este parámetro?

- A) 1 punto
- B) 2 puntos
- C) 3 puntos
- D) 0 puntos
- E) No se puede calcular sin conocer las otras variables

PREGUNTA 3

Lactante de 11 meses con cuadro respiratorio agudo. Al examen: cianótico, muy taquipneico, con retracción cervical marcada y al auscultar no se escuchan sibilancias ni murmullo pulmonar. ¿Cuál es la interpretación correcta de la ausencia de sibilancias?

- A) El paciente no tiene obstrucción bronquial, corresponde a 0 puntos en sibilancias
- B) Indica silencio pulmonar por obstrucción severa, corresponde a 3 puntos
- C) Sugiere que el diagnóstico no es un SBO sino otra patología
- D) Corresponde a 1 punto porque no hay sibilancias audibles
- E) Se debe esperar a que mejore con broncodilatador para reevaluar

RESUMEN: SCORE DE TAL

El score de Tal es la herramienta clínica utilizada para evaluar la severidad del síndrome bronquial obstructivo (SBO). Se clasifica como leve (0-5 puntos), moderado (6-8 puntos) y severo (9-12 puntos, siendo 12 el máximo). Evalúa cuatro variables clínicas: frecuencia respiratoria, uso de musculatura accesoria, cianosis y sibilancias, cada una puntuada de 0 a 3 según intensidad. La frecuencia respiratoria se puntúa según los siguientes cortes: menor a 30/min = 0 puntos, 30-44/min = 1 punto, 45-59/min = 2 puntos, y 60 o más/min = 3 puntos. El patrón es que empieza en 30 y sube de 15 en 15. En menores de 6 meses, se suman 10 a cada punto de corte (40, 55 y 70 respectivamente). El uso de musculatura accesoria progresa de abajo hacia arriba: 0 puntos sin uso, 1 punto subcostal, 2 puntos intercostal y 3 puntos tiraje cervical. Esto es opuesto a la laringitis obstructiva donde la progresión es de arriba hacia abajo. La cianosis se clasifica como: 0 puntos sin cianosis, 1 punto perioral con el llanto, 2 puntos perioral constante y 3 puntos cianosis generalizada. Las sibilancias se clasifican como: 0 puntos sin sibilancias, 1 punto espiratorias solamente, 2 puntos inspiratorias y espiratorias, y 3 puntos audibles sin fonendoscopio o silencio pulmonar. Es importante distinguir el silencio pulmonar: si el paciente está bien y sin sibilancias, el puntaje es 0; pero si está cianótico, taquipneico y con uso de musculatura accesoria sin auscultar sibilancias, el silencio pulmonar indica gravedad extrema (3 puntos) y sugiere un SBO muy severo.